

Fecha Última Actualización: 03-03-2023 9:55:52

Página 1 de 4

### Información Paciente

**Nombre** : Erika Angelica Plaza Santelices  
**Edad** : 47a 2m 10d  
**Dirección** : Canto General 0372 Dpto. 32

**Rut** : 13.041.809-0  
**Fecha Nacto**: 21/12/1975  
**Comuna** : La Granja

**N° Archivo** : 9917347  
**Sexo** : Femenino  
**Teléfono** : 9 7259 7606

**N° Epicrisis**  
**343661**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 10/01/2023 00:55

**Días Estadía**: 52

**Unidad de Egreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Egreso** : 03/03/2023 09:03

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Insuficiencia hepática

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

EPICRISIS ERIKA PLAZA SANTELICES  
03/03/2023

FI CASR: 10/01/2023  
FI UCI: 29/01/2023

Antecedentes:

Medicos: HTA, trastorno del ánimo, vía aérea difícil, daño hepático crónico OH

Cirugías: no.

Medic: Sertralina, Zopiclona.

Alergias a Medicamentos: (-)

Tabaco: no OH crónico, 3 cuartos de botella de pisco diaria Drogas: no

Motivo de consulta: derivada de HPH. Hospitalizada entre el 18.12.22 y el 10.1.23 por:

->Shock séptico e hipovolémico por Sd. diarreico Ag e ITU por E. coli MS ( Ceftriaxona x 9 días)

->29/12/ 22 sepsis 2° a bacteriemia por KPN BLEE, manejada con Imipenem x 14 días ( finaliza 12.1.23)

->7.1.23 Sd febril con urocultivo (+) ERV, tratada con Linezolid desde el 08/01 al 14.1.23

->Hepatitis alcohólica

->AKI KDIGO III por NTA con requerimiento de TRR desde el 21/12 (por catéter femoral derecho retirado el 17.1.23) y última el 12.1.23.

->Hipoglicemia recuperada.

Exámenes:

->Ecocardiograma 09/01 que informa HVI excéntrica con FEVI normal, cavidades derechas normales, shunt intrapulmonar presente y significativo.

->TAC trifásico de abdomen que informa daño hepático incipiente, con ascitis y esplenomegalia, colelitiasis y coledocolitiasis, quistes renales simples, y quiste con contenido denso obs hemorrágico vs proteináceo en el riñón derecho (Bosniak II).

Se traslada a CASR para evaluación por equipo de transplante

Fecha Epicrisis : 03/03/2023 09:55

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:36

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 03-03-2023 9:55:52

Página 2 de 4

Evolución en Sala 13/01-29/01

Completa evaluación y estudio para trasplante hepático.

Obtiene pase cardiológico, de salud mental, evaluación por anestesia.

Inicia NPTC el 21.1.23 por desnutrición severa

Eco renal 19/01 --> signos de nefropatía médica bilateral

Evoluciona con ictericia progresiva, hipereosinofilia y encefalopatía hepática.

25/01 Se rescata SOC inflamatorio, nitritos (+) y bacterias abundantes. Se inicia manejo empírico con 1 gr de amikacina EV (meropenem + Linezolid recibe sólo 1 día). Urocultivo con KPN BLEE tipo KPC, se mantiene amikacina. Evoluciona con PCR estable peri 70, afebril; el día 29/01 con elevación de creatinina de 2.0 a 3.3, se sospecha AKI secundaria a amikacina, por lo que se rota a Ceftazidima/avibactam.

Se evidencia caída de Hb de 7.2 -> 6.5 y Na 130 -> 125 se indica SF 3% 150 ml en bolo, Transfusión 2 U GR filtrados e irradiados, se avisa a EDA de turno

Se intuba para protección de vía aérea e inicio de DVA; es trasladada a UCI

Evolucion en UCI 29/01 al 03/03

HDN y CV: hitos relevantes:

->requerimientos de NAD suspendido 09/02, con perfusion clinica y lactato normal

->Quiebre el 14/02, con elevacion de transaminasas + caída Hcto/Hb + eco doppler con trombosis arteria hepática. Reinicia DVA dosis moderadas y se politransfunde. Reexplorada el 14/02 con hemoperitoneo masivo.

->El 16/02 con HDA, salida de sangre x SNG de 500cc. Reexploracion en pabellón. Regresa sin DVA, nuevamente politransfundida.

->Desde esa fecha, sin nuevos requerimientos de DVA, lactato normal, Hb>7.0

->Sangrado rectal persistente antiguo, coagulos++, sin indicacion qx de urgencia.

->Anasarca clinica; oligoanurica, se mantiene con indicacion de TRR.

->Transfusiones seriadas para optimizar Hcto y Tx de PQT

->Nuevo quiebre HDM 01/03 pm, requiriendo de dosis elevadas de NAD y taquicardia sinusal. Abdomen tenso. TAC trifasico sin sangrado activo pero con hematoma perihepatico significativo, mal flujo arteria hepática. Regresa a pabellón con shock hemorragico más sd compartimental asociado, con doble DVA suspendida tras laparotomía. Regresa a UCI palida, mal perfundida, sin DVA, PAM 103, RS. Hcto 20%. Ultimo balance transfusional: 6 UGR, 8 U PQT, 4 PFC, 1 pool crioprecipitado + octaplex

Sigue con sangrados x drenaje tubular y hematoquezia, plaquetopenia severa, CID refractaria, probable hemolisis.

->02/03 se discute ampliamente caso con equipos tratantes, evolucion tórpida, CID, hemolisis, plaquetopenia severa. Bacteriemia persistente por Enterococo faecium Van B. Higado de shock, vía biliar isquémica. Sin posibilidad de re-trasplante e n estas condiciones, por lo que se decide limitar esfuerzo terapéutico.

Respiratorio: deterioro gasométrico en relación a hipervolemia, con ultrafiltracion optimiza intercambio gaseoso. Es extubada el 10/02 con salida a CNAF y luego VNI. Evoluciona muy congestiva, no logra consolidar weaning, debiendose reintubar en pabellón en contexto de shock hemorragico con hemoperitoneo masivo (14/02). Desde esa fecha se mantiene intubada en VM, sin conflicto de intercambio. En SAS3-4 con BIC de fentanyl como analgesia en modo PA/C 21% 14/8, no se ha avanzado en weaning por anasarca y miopatía.

Tras nuevo quiebre hemodinámico del 02/03 se deja con sedación profunda en modo VA/C protectora, en SAS1. Se decide mantener con sedoanalgesia para optimizar medidas de confort en pcte con limitación de esfuerzo terapéutico.

Renal: siempre oligoanurica, con parametros nitrogenados estacionarios. Anasarca; mantiene apoyo con HD/UFA en forma casi diaria. AKI KDIGO3 no resuelta.

Infeccioso: estuvo con terapia antibiótica dirigida x sepsis de foco urinario x KBP KPC ( 17 días de ceftazidima/avibactam, suspendido 16/02)

Pancultivada el 13/02. Destaca:

- HC 1 y 2 (negativos)

- Lumen medial de check (+) candida albicans

- Lumen proximal CVC (+) candida albicans

- Lumenes de CHD(-)s

Inició anidulafungina (15/02). Se retiran CVCs 17/02, con cultivos de puntas (3 CVCs) más HC periféricos

Fecha Epicrisis : 03/03/2023 09:55

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 03-03-2023 9:55:52

Página 3 de 4

Líquido peritoneal del 14/02 con Enterococo faecium Van B, se deja linezolid x 24 hrs y se modifica a tigeciclina con carga de 200 mg el 17/02; HCs 1 y 2 del 17/02 a las 11 hrs con Enterococo faecium van B, se decide mantener tigeciclina y se agrega daptomicina previo consentimiento de infectología (23/02)

En resumen, 2 focos activos:

Sepsis abdominal con peritonitis bacteriémica x enterococ van A y B, en tto con tigeciclina + daptomicina.

-> 28/02 se deja nuevamente linezolid x bacteremia persistente (control HC 27/02 ERV B)

Sepsis abdominal + candidemia (candidiasis invasora) en tto con adinulafungina (cultivo de hematoma hepático del 14/02 para candida Albicans)

-> completa 14 días 01/03

02/03, se decide suspender antibioterapia y no tomar más cultivos ante futilidad terapéutica.

Bacteriemia persistente, CID refractaria, falla hepática reagudizada x hígado de shock, falla renal aguda en diálisis.

Hepatología: en seguimiento por equipo de hepatología y transplante.

Fue transplantada el 08/02/23, CIRUGÍA 4 hrs, sin mayores incidentes. Transfundida más blood saver que recuperó 2000cc. Recibe basilixumab

Eco doppler (09/02) sin alteraciones sugerentes de trombosis isquemia. Colección hepática derecha compatible con hematoma, ascitis.

Evolución favorable hasta 14/02 con elevación significativa de transaminasas. Eco doppler con trombosis arterial, se repara en pabellón (arteria disecada y trombozada)

Seguimiento de p. hepáticas bajando favorablemente

Iniciado tacrolimus, pero se suspende x sepsis, manteniéndose solo con corticoides ev 2° dosis de basilixumab (12/02).

Se inicio profilaxis con aciclovir y cotrimoxazol forte

Quiebre el día 02/03, con hígado de shock, necrosis vía biliar, isquemia hepática significativa. Elevación significativa de transaminasas, LDH > 15.000

Se plantea necesidad re-transplante ante pérdida de viabilidad de injerto hepático, sin embargo, estado crítico de paciente no la hace candidata, quedando fuera de manejo médico-quirúrgico.

Quirúrgico COLOPROCTO: HDB secundario a hemorroides con shock hemorrágico, politransfundida, control hemostático en UCI. Luego se instala packing anal en pabellón 02/02, retirado en UCI el 07/02 sin incidentes.

Se revisa en pabellón (16/02), con sangrado activo de mucosa ano rectal, se hace hemostasia con surgicel

Hemorroides ligadas, condilomas no sangrantes.

Nueva EDA 22/02, mejor de mucosa gástrica, úlcera cicatrizada. Se reinstala SNG. Se realiza luego colonoscopia con abundantes restos hemáticos y coágulos.

27/02 EDA mas capsula endoscopica. Colonoscopia sin sangr a d o activo, mucosa con restos de coágulos

Mantiene hematoquezia casi diaria. Último evento reportado el 02/03 pm.

Profilaxis: IBP dosis ajustadas por HDA

Diagnósticos:

34° día en UPC

52 días de hospitalización CASR (75 días de hospitalización totales)

23° post operatorio Transplante hepático

Trombosis arteria hepática más disección de la misma (14/02) con reparación primaria

Politransfundida

Reexplorada 16/02: reexploración Qx + EDA + revisión anorectal

Post operatorio inmediato de:

-> Relaparotomizada 02/03: hemoperitoneo masivo + trombectomía arteria hepática

-> 3 djes tubulares + 1 dje JP

-> Politransfusión.

Fecha Epicrisis : 03/03/2023 09:55

Página 3 de 4

# Epicrisis Hospitalaria

## ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 03-03-2023 9:55:52

Página 4 de 4

Bacteriemia persistente x Enterococo faecium Van B  
Shock hemorrágico, sin control hemostático  
CID refractaria  
Plaquetopenia severa  
Higado de shock  
->Isquemia hepática significativa  
->Necrosis vía biliar  
AKI KDIGO3 persistente, oligoanurica  
Anasarca  
Miopatía paciente crítico  
Weaning prolongado

### Antecedentes:

Shock séptico de foco urinario por Klebsiella pneumonia BLEE Tipo KPC tratada  
Daño Hepático Crónico OH

Paciente fallece a las 09:10 h del 03.03.2023

### Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - Bacteriemia persistente x Enterococo faecium Van B  
Shock hemorrágico, sin control hemostático  
CID refractaria  
Plaquetopenia severa  
Higado de shock  
->Isquemia hepática significativa  
->Necrosis vía biliar  
AKI KDIGO3 persistente, oligoanurica

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece a las 09:10 h del 03.03.2023

### Plan Post Alta

### Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

### Controles

INTERNO

Becado/Residente



Maria Alejandra Cartes Lagos  
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 03/03/2023 09:55

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:36

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar